ТАЕН БОНУС

Дневник на грешките след дежурство

След всяко дежурство записвайте без самообвинение моментите, в които сте пропуснали, забавили или сте казали «на косъм»; вижте моделите и със седмичния преглед не допускайте една и съща грешка втори път.

Съдържание

Защо дневник на грешките?

Глава 1 · Какво се записва

Глава 2 · Категории причини

Глава 3 · Шаблон за запис (страници за попълване)

Глава 4 · 10 въпроса за размисъл

Глава 5 · Седмичен план за преглед

Глава 6 · Месечна таблица на моделите

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Защо дневник на грешките?

Няма специализант, който да не греши; има специализант, който не се учи от грешките си.

> *След дежурство сте уморени и искате да забравите пропуснатата находка. Но на следващото дежурство тази находка пак ще се крие на същото място.*

Този дневник не е инструмент за обвинение. Целта му е да разберете не **кой** е сгрешил, а **защо** се е стигнало до грешката, и да укрепите системата си (реда на разчитане, прозорците, комуникацията).

Правило за поверителност

Не пишете в дневника име на пациента, номер на протокол, дата на раждане или каквато и да е информация, по която пациентът може да бъде идентифициран. Споменавайте случая с общи изрази като «възрастен мъж, КТ на мозък, субдурален». Ако Вашата институция има система за докладване на инциденти, този дневник не я замества; съобщавайте и в системата на институцията инцидентите, които подлежат на докладване.

Правило: 10 минути

Направете записа, преди да си тръгнете от дежурството или когато се приберете, докато паметта Ви е свежа. Кратък и честен запис е по-добър от дълъг запис, който никога не е написан.

ГЛАВА 1

Какво се записва

Не само големите грешки; всеки момент, който е възможност за учене.

ВИД	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПРИМЕР
Пропусната находка	Находка, която я има на образа, но я няма във Вашето описание.	Тънък субдурален хематом, коригиран от Вашия ръководител.
Погрешна интерпретация	Находка, която е видяна, но е назована погрешно.	Флеболит, описан като камък в уретера.
На косъм (near-miss)	Ситуация, уловена, преди да се превърне в грешка.	Пневмоторакс, забелязан при последната проверка преди изпращане на описанието.
Забавяне	Правилно, но закъсняло разчитане или съобщение.	Съобщаване за свободен въздух едва след описанието.
Проблем в комуникацията	Информацията не стига до правилния човек в правилното време.	Погрешно разбиране от клиницист заради описание с неясна формулировка.
Протокол / безопасност	Проблем при избора на изследване, с контраста или с безопасността при ЯМР.	Пропуснат въпрос за алергия преди контраст.
Добро улавяне	Нещо, което сте направили правилно и искате да повторите.	Изоденсен субдурален хематом, открит чрез сравнение с предишно изследване.

ГЛАВА 2

Категории причини

Свържете всеки запис с една или няколко причини; оттук излизат моделите.

КАТЕГОРИЯ	ПОПИТАЙТЕ СЕ	ВЪЗМОЖНА КОРЕКЦИЯ
Перцептивна (не я видях)	Находката беше на екрана, но погледът ми не стигна дотам?	Да разширите постоянния си ред на разчитане; да добавите местата, където находките се крият.
Ранно спиране	Спрях ли да преглеждам, след като намерих първата находка?	Правилото «не спирайте при първата находка»; проверка за втора находка.
Липса на знания	Видях находката, но не знаех какво е?	Да изучите темата; преговор от атласа и речника.
Техника	Грешен прозорец, липсваща равнина, липсваща серия?	Контролен списък за прозорци и реконструкции.
Липса на сравнение	Имаше предишно изследване, но не го погледнах?	В стъпка ПОДГОТВЕТЕ задължително да се отваря предишното изследване.
Клинична информация	Не знаех ли клиничния въпрос или анамнезата?	Да прочетете направлението; при нужда да се обадите на клиницист.
Комуникация	Съобщението закъсняло ли е, било ли е неясно, направено ли е на грешния човек?	SBAR и запис на съобщението.
Система и умора	Повлияха ли натоварването, прекъсването, безсънието?	След прекъсване да започнете отначало в региона; почивка; да поискате помощ.

ГЛАВА 3

Шаблон за запис

По един формуляр за всеки случай. Можете да размножите страниците по-долу, като ги разпечатате.

Когато попълвате формуляра, първите три реда пишете за случая, а следващите — за собствения си процес. Последният ред е най-важен: какво ще направите различно следващия път?

Запис 1

Дата на дежурството · час	
Вид (пропусната / погрешна интерпретация / на косъм / забавяне / комуникация / безопасност / добро улавяне)	
Случай (анонимизиран): възрастова група, изследване, клиничен въпрос	
Какво се случи? (обективно, кратко)	
Как беше забелязано? (аз / моят ръководител / клиницистът / контрол)	
Категория на причината	
Имаше ли последствия за пациента? Съобщено ли е?	
Какво ще направя различно следващия път	

Запис 2

Дата на дежурството · час	
Вид	
Случай (анонимизиран)	
Какво се случи?	
Как беше забелязано?	
Категория на причината	
Последствия за пациента · съобщаване	
Следващия път	

Запис 3

Дата на дежурството · час	
Вид	
Случай (анонимизиран)	
Какво се случи?	
Как беше забелязано?	
Категория на причината	
Последствия за пациента · съобщаване	
Следващия път	

Бърз запис в края на дежурството (за няколко малки случая в едно дежурство)

ЧАС	ИЗСЛЕДВАНЕ	КАКВО СЕ СЛУЧИ	ПРИЧИНА	УРОК

ГЛАВА 4

10 въпроса за размисъл

След като напишете запис, отговорете на тези въпроси за най-важния случай.

1. Къде се крие тази находка на образа и защо не погледнах там?

2. В коя от 4-те стъпки (ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ) имаше засечка?

3. Бях ли отворил правилния прозорец, секвенция или равнина?

4. Имаше ли предишно изследване и сравних ли го?

5. Какво трябваше да знам за клиничния въпрос и анамнезата?

6. Кога за първи път забелязах находката и кога я съобщих? Какво се случи междувременно?

7. Имаше ли момент, в който трябваше да се обадя на моя ръководител? Защо не се обадих или се обадих късно?

8. Изиграха ли роля в този случай умората, натоварването или прекъсването?

9. Каква стъпка ще добавя към реда си на разчитане, за да не повторя същата грешка?

10. Как бих разказал на колега с едно изречение какво научих от този случай?

ГЛАВА 5

Седмичен план за преглед

Една сесия седмично; стъпката, която превръща записите в учене.

1. **Прочетете записите.** Прочетете всички записи от седмицата от началото до края; включете и таблицата с бързите записи.
2. **Пребройте категориите.** Коя категория причини се повтаря най-често тази седмица?
3. **Изберете една тема.** За най-често повтарящата се находка или регион определете една-единствена тема за изучаване през тази седмица.
4. **Върнете се към образа.** Ако е възможно и в съответствие с правилата на Вашата институция, погледнете отново образите на съответните случаи; този път сами намерете находката.
5. **Актуализирайте реда си на разчитане.** При нужда добавете стъпка към постоянния си ред или точка към контролния си списък.
6. **Споделете с Вашия ръководител.** Обсъдете накратко избран случай на визитация или в подходящ момент.
7. **Записвайте и добрите улавяния.** Отбележете едно нещо, което сте направили правилно през седмицата; да знаете кое работи също е учене.

Формуляр за седмично обобщение

СЕДМИЦА	БРОЙ ЗАПИСИ	НАЙ-ЧЕСТА ПРИЧИНА	ТЕМА ЗА ИЗУЧАВАНЕ	СТЪПКА, ДОБАВЕНА КЪМ РЕДА МИ НА РАЗЧИТАНЕ
1				
2				
3				
4				

ГЛАВА 6

Месечна таблица на моделите

В края на месеца отбележете кои категории и региони са се повтаряли.

КАТЕГОРИЯ НА ПРИЧИНАТА	НЕВРО	ГРЪДЕН КОШ	КОРЕМ	МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА	ПЕДИАТРИЯ / БРЕМЕННОСТ
Перцептивна					
Ранно спиране					
Липса на знания					
Техника					
Липса на сравнение					
Клинична информация					
Комуникация					
Система и умора					

Урокът на месеца

Не забравяйте

Увеличаването на броя на записите в дневника Ви не е лош знак; показва, че гледате по-внимателно. Важното е една и съща причина да намалява в рамките на месеца.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Дневникът Ви е готов; цикълът е завършен.

Преди следващото дежурство **«Протокол за дежурство: 50 спешни сценария»** Отворете отново файла (Основен материал) и прегледайте сценариите за региона, който се появява най-често в дневника Ви. Не сте сами на дежурство.